Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Judicial da Comarca de Marau

Rua Irineu Ferlin, 1098 - Bairro: Cidade Alta - CEP: 99150000 - Fone: (54) 3342-1011 - balcão virtual (54) 99714 9242 - Email: frmarau2vjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM INFÂNCIA E JUVENTUDE Nº 5001221-32.2023.8.21.0109/RS

REQUERENTE: ELISE FERNANDA PAZ DO SANTOS
REQUERENTE: GABRIELLY DOS SANTOS VIEIRA
REQUERIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação ordinária proposta por GABRIELLY DOS SANTOS VIEIRA, representada por sua genitora, em desfavor de ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Narrou que é portador da moléstia indicada CID 10 – L20.8 e que necessita para o seu tratamento fazer o uso do medicamento DUPILUMABE 200MG, na dosagem inicial de 400MG, totalizando 2 frascos; as demais doses subsequentes serão de 200MG a cada 2 semanas, totalizando 2 frascos ao mês, pelo período aproximado de 24 meses Disse que o não uso do fármaco pode ocasionar agravo do quadro clínico e que não dispõe de recursos para suportá-lo. Discorreu sobre o Direito aplicado ao caso. Requereu a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o demandado forneça o medicamento indicado. Ao fim, pugnou pela procedência da ação. Requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Juntou documentos (evento 1, INIC1).

Encaminhados os autos ao E-NATJUS, a Nota Técnica foi anexada ao processo (evento 6, NOTATEC2).

Deferido o pleito liminar da autora (evento 8, DESPADEC1).

Citado, o demandado apresentou contestação. Asseverou a necessidade de observação da repartição de competência dentro do Sistema Único de Saúde a fim de direcionar a demanda ao responsável pelo seu fornecimento. Reforçou a necessidade de comprovação dos critérios estabelecidos pelo Tema 106 do STJ. Requereu a improcedência da ação. Juntou documentos (evento 72, CONT1).

Réplica pela parte autora (evento 79, PET1).

Instadas as partes acerca da dilação probatória (evento 81, DESPADEC1), ambas manifestaram desinteresse (evento 86, PET1 e evento 89, PET1).

O Ministério Público exarou parecer (evento 103, PARECER1).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a decidir.

Trata-se de demanda através da qual pretende a autora a condenação do Estado ao fornecimento do fármaco necessário para o tratamento da moléstia que o acomete.

O direito fundamental social à saúde está previsto no art. 196 da Constituição Federal de 1988 – CF/1988, o qual determina ser dever do Estado, no sentido *lato sensu*, a promoção das medidas necessárias ao atendimento ao direito à saúde. Já o art. 6º da Carta Magna, inserida no título dos direitos e garantias fundamentais, assegura que a saúde é um direito social. Tal norma goza de eficácia plena e aplicabilidade imediata, como expressamente prevê o § 1º do art. 5º da CF/1988.

Há em nosso ordenamento jurídico normas infraconstitucionais que regulamentam o sistema público de saúde, versando sobre a repartição de competências e atribuições, com o objetivo de descentralizar os serviços, garantindo, assim, uma maior efetividade às políticas públicas destinadas ao atendimento das necessidades de saúde da população. Veja-se, nesse sentido, a Lei 8.080/90, em âmbito Federal, e a Lei 9.908/93, em âmbito Estadual, sem falar nas inúmeras normas de caráter administrativo.

Assim, sem olvidar que o direito à saúde se insere no rol dos direitos fundamentais, cabe considerar que o programa de assistência farmacêutica mantido pelo SUS e gerido pelos Estados e Municípios possui alguns critérios que devem ser observados, sob pena de inviabilizar o sistema, em prejuízo dos próprios usuários.

Especificamente quanto à política de assistência farmacêutica, foram elaboradas listas de medicamentos básicos e essenciais (cujo fornecimento é atribuído aos Municípios), especiais e excepcionais (a serem fornecidos pelo Estado). Respeitar os critérios adotados pelo SUS e suas respectivas regras de competência é uma forma de viabilizar o funcionamento do sistema e a correta alocação de recursos destinados a abastecer a farmácia pública. De outro modo, desestruturar-se-á o sistema, dificultando (quiçá inviabilizando) em última análise, a adequada prestação do serviço de saúde.

Sabidamente, é dever do Poder Judiciário analisar minuciosamente toda exigência que necessite recursos econômicos do Poder Público. Dessa forma, sem abandonar a ideia de que o direito à saúde obriga solidariamente União, Estados e Municípios, tenho que, quando se trata de fornecimento de medicamentos, as listas devem ser observadas, evitando que um ente seja onerado com o fornecimento de um medicamento que não é de sua atribuição.

E, em se tratando de medicamentos que não integram nenhuma das listas de competência, afastar-se-ia, à primeira vista, a responsabilidade do demandado pelo seu fornecimento, salvo se demonstrada a existência de similares disponibilizados pelo SUS e a consequente ineficácia ou inadequação desses para tratamento da enfermidade, ocasião em que tal orientação deve ser relativizada.

Contudo, considerando que se trata de medicamento não incorporado na política pública do SUS, com registro na ANVISA, conforme se infere da Nota Técnica (evento 6, NOTATEC2), e com custo anual de aproximadamente R$ 255.000,00, conforme orçamentos (evento 1, OUT21), de acordo com o acórdão de mérito do *Leading Case* RE 1366243, do respectivo Tema 1234, não há que se falar em inclusão da União no polo passivo.

> *"I – Competência 1)* ***Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.*** *1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa."*

<u>Na hipótese dos autos</u>, restou comprovado que a parte autora necessita utilizar, DUPILUMABE 200MG, na dosagem pleiteada (evento 1, LAUDO16 e evento 1, LAUDO17).

Saliente-se que a necessidade do medicamento está amparada em documentação idônea, conforme laudos supramencionados, lavrados por profissionais médicos, um que acompanha o autor e que justificadamente prescreveu tal medicamento.

Dessa forma, sendo o fármaco imprescindível ao tratamento da patologia que acomete a autora, a responsabilidade para fornecê-lo é do ente públicos demandado.

Aliás, o STJ ao julgar o Tema 106, definiu os requisitos para fornecimento de medicamentos não constantes da listagem do SUS, modulando os efeitos, no sentido de que os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento.

Nesse sentido, cite-se a decisão do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, sendo Relator o Ministro Benedito Gonçalves, publicado no dia 04 de maio de 2018, referente ao TEMA 106 do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte ementa:

> *"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.*
>
> *1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando* ***fazer*** *uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.*
>
> *2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.*
>
> *3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.*
>
> *4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.*
>
> *5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015."*

Isto é, conforme o julgamento, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

No presente caso, todos os requisitos foram provados, pois (i.) há laudo médico que demonstra a imprescindibilidade e necessidade de fornecimento do insumo; (ii.) a incapacidade financeira de arcar com o custo do tratamento se presume pelo fato do autor ser assistido pela Defensoria Pública, (iii.) quanto ao registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, evidencia-se a sua inclusão, tendo em vista que é comercializado nas farmácias, apenas ausente a dispensação pelo SUS.

Assim, é justo o pedido da parte autora, na busca por socorro do Judiciário para garantir o direito à saúde e à vida, uma vez que comprovada a necessidade em receber o insumo ora pleiteado, conforme diagnóstico e prescrição médica trazidos aos autos, bem como do dever do demandado em fornecer o referido com vista à preservação do direito social à saúde e ao cumprimento dos ditames constitucionais.

O atestado médico do profissional devidamente habilitado que acompanha o tratamento da parte autora constitui prova suficiente para embasar a pretensão por ela explicitada na inicial, bem como a adequação do tratamento prescrito para a doença que lhe acomete.

Saliento que a Nota Técnicas foi certeira ao mencionar que o fármaco é indicado para tratamento da doença que acomete a autora e, havendo indicação expressa do médico que as opões disponíveis na rede pública já foram utilizadas, a procedência da pretensão autoral se impõe.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **GABRIELLY DOS SANTOS VIEIRA**, em desfavor de **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, para **CONDENAR** o réu a fornecer ao autor o medicamento DUPILUMABE 200MG, na dosagem inicial de 400MG, totalizando 2 frascos; as demais doses subsequentes serão de 200MG a cada 2 semanas, totalizando 2 frascos ao mês, nos termos do pedido inicial, observados os referidos parâmetros de manutenção, sob pena de bloqueio de valores em caso de descumprimento.

Em consequência, ratifico a tutela provisória concedida (evento 8, DESPADEC1), pelo que esta sentença gera efeitos imediatos (CPC, art. 1012, § 1º, V).

O Estado do Rio Grande do Sul fica dispensado do pagamento de honorários, em razão de a parte autora ser assistida pela Defensoria Pública do Estado, indo ao encontro da Súmula n° 421 do STJ, que reza "*os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença*".

Sem condenação em custas processuais (Lei Estadual nº 14.634/2014, art. 5º, I e p. ún. c/c Lei 8.069/90, art. 141, § 2º).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em caso de interposição de recurso por qualquer dos litigantes, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, proceda-se à remessa dos autos ao Tribunal competente para apreciação.

Na hipótese, se a Serventia observar eventual alegação de preliminar em contrarrazões, deverá ser intimada a parte apelante para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, observado o disposto pelo art. 1.009, §2o, do CPC.

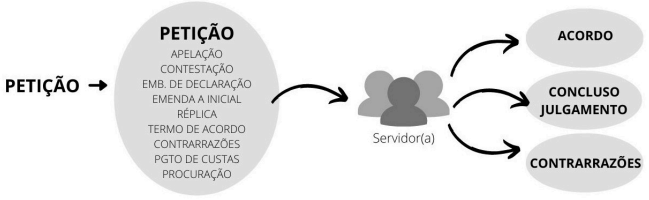
Com o trânsito em julgado e nada mais sendo postulado pelas partes, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Diligências legais.

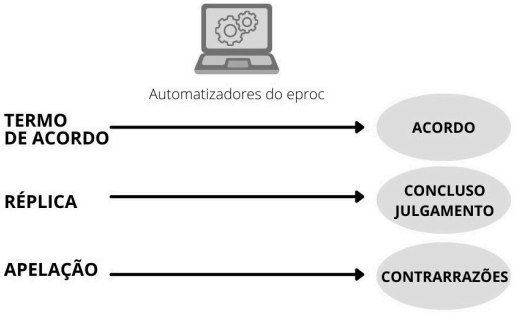
Sr.(a) Advogado(a), nomear corretamente as petições contribuem muito para a celeridade da tramitação do processo.

Entenda como sua petição chega às unidades jurisdicionais pelo sistema Eproc:

Todos os documentos nomeados simplesmente "PETIÇÃO" são direcionados ao localizador do sistema "PETIÇÃO", sendo necessária a triagem manual de cada processo para redirecionamento ao localizador correto.



Os documentos nomeados corretamente são automaticamente direcionados aos localizadores específicos do sistema, abreviando-se o tempo para conclusão ou andamento do processo, como nos exemplos abaixo.



Documento assinado eletronicamente por **PLINIO LOPES DA SILVA, Juiz de Direito**, em 22/01/2025, às 15:56:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10073650487v5** e o código CRC **9c98b618**.